

熊仿杰的个案护理

病区	65W	床号	15	姓名	熊仿杰
性别	男	年龄	76	住院号	703348
诊断	急性胆囊炎；高血压病 1 级（高危）；慢性胃炎				
一、主要病情					
1. 现病史	2026/7/15 患者因无明显诱因下出现胸闷、上背痛、上腹部隐痛伴恶心 2026/07/17 因保守治疗无效来院，为进一步诊治收住我科。完善相关检查后，当日在全麻下行腹腔镜胆囊切除术，术后入 ICU。 2026/07/18 安返病房。 患者现生命体征平稳，今为手术后第 10 天，予一级护理，进半流质。				
2. 既往史	疾病史： 1. 高血压病史 29 年，长期口服降压药物络活喜，血压控制尚可； 2. 脑动脉、颈内动脉粥样硬化，双侧颈动脉斑块，曾短暂脑缺血发作（TIA）； 3. 肺部肿瘤，2011 年 7 月行左上肺叶切除+纵隔淋巴结清扫术； 4. 慢性肾功能不全，长期口服肾保护药物；高尿酸血症； 5. 慢性胃炎、结肠息肉史；前列腺增生。				
3. 特殊检查	2026-7-22 血管 CT 示双侧颈动脉斑块伴管腔轻度狭窄；右侧椎动脉较对侧纤细，左侧椎动脉颅内段钙化斑块伴管腔轻度狭窄。 2026-7-27 CTA 示左前降支近段及第二钝缘支混合斑块，左前降支局段重度狭窄，余管腔中度狭窄，左前降支浅表性心肌桥。				
4. 异常化验	患者 07/24 化验指标示： 1. C-反应蛋白：34.1mg/L，纤维蛋白原：557mg/dL，均升高，提示感染炎症 2. 白蛋白：28g/L，降低，低蛋白血症，机体营养不良 3. D-二聚体：5.61mg/L，升高，高凝状态，血栓高危				
二、目前主要治疗措施					
治疗原则	1. 人血白蛋白 10g ivgtt qd				

	2. 那屈肝素钙注射液 3800IU ih q12h 3. 阿托伐他汀钙片 20mg po qn 4. 非布司他片 20mg po qd 5. 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) 5mg po qd 6. 可多华 4mg po qd 7. 富马酸比索洛尔片 5mg po qd
三、目前主要观察要点	
1. 生命体征	T36.1℃, P 72 次/分, R 18 次/分, Bp 133/85 mmHg, SpO ₂ 98 %, 疼痛 1 分。
2. 伤口及导管	伤口渗出: 无, 敷料清洁干燥 目前置管: 1. 右前臂留置针妥善固定, 穿刺处无红肿无渗出。 2. 鼻氧管妥善固定, 氧流量 3L/min。
3. 体位与活动	卧位: 主动卧位 活动情况: 患者已下床活动
4. 自理能力	自理能力 45 分, 为中度依赖, 予一级护理。
5. 跌倒风险	跌倒风险临床判定为中风险, 已做好预防宣教, 悬挂防跌倒警示标识。
6. 压力性损伤风险	压力性损伤评估 17 分, 为轻度风险, 做好预防宣教。
7. DVT 风险	评分 5 分, 为极高危风险, 做好预防宣教, 指导患者下肢抬高, 床上主被动运动。
8. 营养风险	NRS-2002 评分 5 分, 有营养风险, 遵医嘱提供营养支持。
9. 医院获得性肺炎风险	评分为 3 分, 为无风险, 做好预防宣教。
10. 手术并发症	无
四、现存及潜在的护理诊断及措施	

(一)现存问题	1. 感染风险 —— 与手术创伤及机体防御能力下降有关 护理措施： 1. 动态监测体温变化曲线，若出现发热及时通报医师，并行物理或药物降温处理。 2. 落实无菌操作规范，保持伤口敷料外观干洁，不浸湿、不松脱。 3. 关注局部切口表现，随时查看有无红、肿、热、痛或异常渗液等感染征象。 4. 遵医嘱执行抗感染药物治疗，同时注重全身营养支持，可辅以静脉营养以增强抗病能力。 2. 营养失调：低于机体需要量 —— 与术后高分解代谢及半流质膳食限制有关 护理措施： 1. 实施分阶段膳食调整策略：从半流质逐步过渡至软食，遵循由少至多、由稀至稠的原则。 2. 依据肾功能状况，安排优质低蛋白、低盐且易消化的食物，兼顾营养补充与肾脏保护。 3. 定期复查营养相关生化指标，每周称量体重，并观察患者有无早饱、腹胀、恶心等消化道反应。 4. 遵行静脉补液及营养输注治疗，输液期间加强巡视穿刺点，防范静脉炎及输液反应。
(二)潜在问题	1. 潜在并发症：肠粘连 —— 与手术区域创伤、炎性渗出、肠蠕动恢复缓慢有关 护理措施： 1. 鼓励患者术后下床活动，每日分散进行，以促进肠道蠕动。 2. 密切监听肠鸣音变化，记录首次排气及排便时间，关注有无持续性腹胀或阵发性腹部绞痛，异常时即刻上报。 3. 对患者及家属着重说明下床活动对预防肠粘连的意义，出院后鼓励规律活动，若反复腹痛腹胀应及时复诊。

	1. 有深静脉血栓形成可能:与术后血管损伤，D-二聚体指标增高有关。 护理措施： 1. 开展 VTE 防治知识宣教，指导患者增加日常饮水量，合理调配膳食。 2. 卧床期间将双下肢垫高，避免膝下硬物支撑及髋部过度屈曲，注意肢体保暖。 3. 协助或指导患者规律进行踝关节屈伸环绕运动及股四头肌等长收缩训练，强化小腿肌肉泵作用。 4. 合理选择静脉通路，优先选用细口径、短留置时间的导管，避免在下肢或已有血栓风险的肢体穿刺。 5. 每日观察双下肢围度、皮色及皮温，询问有无肢端麻木、酸痛或沉重感，发现异常及时记录并报告。
五、健康教育	
(一) 饮食指导	1. 遵循低盐、优质蛋白原则，控制动物脂肪摄入，忌食蛋黄、肥肉、动物内脏及油炸类食品。 2. 采用少食多餐模式，由半流质逐步过渡至软食，最终恢复正常膳食，过程需循序渐进，切勿急于求成。
(二) 伤口/导管	伤口方面： 1. 敷料应保持外观干洁，避免手部直接接触创面区域。 2. 若敷料被渗液浸透、松脱或污染，应联系医生更换。 3. 伤口周围皮肤需保持清洁，一旦出现红、肿、热、痛等异常，及时向医生反映。 导管方面： 向患者及家属逐一说明各类导管的名称、留置目的及重要性，取得配合。
(三) 药物指导	1. 抗凝药物：告知患者服药期间需留意皮肤、黏膜有无出血点或瘀斑，伤口渗血时应立即报告；建议使用软毛牙刷清洁口腔，并定期抽血监测凝血功能指标。 2. 降压药物：强调规律服用的必要性，不可自行调整或停药，每日定时测量并记录血压值。
(四) 活动指导	1. 活动强度以少量多次、不产生明显疲乏为准，可每日记录活动时长与步行距离，便于纵向比较康复进展。 2. 活动期间若出现头晕、切口疼痛等不适，应立即中止并就地休息；症状持续不缓解时需呼叫医护人员。

	3. 行走时着防滑鞋具，必须有家属或陪护人员在旁搀扶，严防跌倒意外。
--	------------------------------------

